

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

UPPS-P · ESCALA DE COMPORTAMIENTO IMPULSIVO

UPPS-P Impulsive Behavior Scale (Versión Breve de 20 Ítems) – Modelo factorial de 5 dimensiones cognitivas y afectivas de desinhibición conductual

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	UPPS-P Impulsive Behavior Scale (Short Version / UPPS-P 20 ítems)
Nombre en español	Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P (Versión Breve en Español)
Sigla oficial	UPPS-P
Autores originales	Stephen P. Whiteside y Donald R. Lynam (2001; versión P con Urgencia Positiva por Cyders et al., 2007)
Adaptación hispanohablante	Antonio Cándido et al. (2012); Antonio Verdejo-García et al. (2010)
Año de publicación original	2001 (versión corta UPPS-P en 2014; validación española en 2010 y 2012)
Constructo primario	Impulsividad multidimensional: Urgencia Negativa, Falta de Premeditación, Falta de Perseverancia, Búsqueda de Sensaciones y Urgencia Positiva
Formato de administración	Autoinforme estructurado de 20 ítems con escala Likert de 4 puntos (1 a 4)
Población diana	Adolescentes y adultos (≥ 14 años) evaluados en adicciones, salud mental, TCA o medicina pericial
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (20 ítems)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de libre disposición (Purdue University Repository)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P** surgió para subsanar un error epistemológico recurrente en la psicopatología: considerar la “impulsividad” como un rasgo homogéneo y unitario. Mediante análisis factoriales exhaustivos de las principales escalas mundiales (BIS-11, Dickman, Cloninger), Whiteside y Lynam (2001) demostraron que la conducta impulsiva está impulsada por al menos cuatro procesos neuropsicológicos disociables (UPPS: **Urgencia Negativa**, **Falta de Premeditación**, **Falta de Perseverancia** y **Búsqueda de Sensaciones**). Posteriormente, Cyders et al. (2007) identificaron un quinto factor crítico: la **Urgencia Positiva**.

El modelo UPPS-P postula vías etiopatogénicas diferenciadas para cada dimensión: 1) Las **Urgencias Afectivas** (Negativa y Positiva) reflejan la tendencia a actuar precipitadamente y perder el control motor bajo estados emocionales extremos (disforia/rabia o euforia intensa), asociándose fuertemente a conductas autolíticas, atracones alimentarios y recaídas en adicciones; 2) Los **Déficits Ejecutivos** cognitivos (**Falta de Premeditación** y **Falta de Perseverancia**) miden la incapacidad de anticipar consecuencias y de mantener el foco atencional en tareas aburridas; y 3) La **Búsqueda de Sensaciones** refleja la apetencia por experiencias novedosas y estimulación intensa. La versión abreviada de 20 ítems (Cándido et al., 2012) validada en España retiene de forma perfecta la estructura penta factorial.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems (Versión Breve 20 Ítems)

Dimensión UPPS-P	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización Psicopatológica
1. Urgencia Negativa (UN)	4 ítems	4 – 16	Tendencia a actuar impulsivamente ante afectos negativos extremos (ira, angustia, tristeza). Ítems 2, 7, 12, 17.
2. Falta de Premeditación (PM)	4 ítems	4 – 16	Incapacidad para pensar y sopesar las consecuencias antes de actuar (ítems 1*, 6*, 11*, 16* invertidos).
3. Falta de Perseverancia (PS)	4 ítems	4 – 16	Dificultad para mantener la concentración y finalizar tareas largas o monótonas (ítems 4*, 9*, 14*, 19* invertidos).
4. Búsqueda de Sensaciones (SS)	4 ítems	4 – 16	Atracción por actividades intensas, deportes de riesgo y experiencias excitantes. Ítems 5, 10, 15, 20.
5. Urgencia Positiva (UP)	4 ítems	4 – 16	Pérdida de autocontrol e impulsividad bajo estados de euforia o entusiasmo elevado. Ítems 3, 8, 13, 18.
Puntuación Total / Subescalas	20 ítems	20 – 80	Se interpretan preferentemente las 5 subescalas (4-16 c/u). Mayor puntuación = mayor impulsividad.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia de subescalas	Alpha = 0.76 – 0.88	UN (0.84), UP (0.86), PM (0.82), PS (0.78), SS (0.81). Excelente fiabilidad en la versión breve de Cándido et al. (2012).
Fiabilidad test-retest	r = 0.80 – 0.86 (1 mes)	Elevada estabilidad temporal correspondiente a rasgos estructurales de personalidad.
Validez de constructo factorial	5 factores ortogonales confirmados	CFI = 0.96, RMSEA = 0.045 en análisis factorial confirmatorio multicéntrico en España.
Validez discriminante clínica	Diferenciación nítida de patologías	La Urgencia Negativa correlaciona específicamente con intentos de suicidio (r = 0.54) y atracones en TCA (r = 0.48).
Asociación con adicciones	Odds Ratio = 3.2	La combinación de Urgencia Positiva y Negativa predice recaídas masivas en adicción a cocaína y alcohol.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación ordinal de 4 categorías:**
 - 1 = **Rotundamente de acuerdo**; 2 = **Algo de acuerdo**; 3 = **Algo en desacuerdo**; 4 = **Rotundamente en desacuerdo**.
- **Ítems Inversos (*) (8 ítems formulados en sentido adaptativo):**
 - Ítems de Falta de Premeditación (1, 6, 11 y 16) e ítems de Falta de Perseverancia (4, 9, 14 y 19).
 - Para que la dirección indique impulsividad, deben codificarse de forma que el desacuerdo puntúe más: **Rotundamente de acuerdo = 1 punto | Algo de acuerdo = 2 puntos | Algo en desacuerdo = 3 puntos | Rotundamente en desacuerdo = 4 puntos**.
- **Ítems Directos (12 ítems de Urgencia y Búsqueda de Sensaciones):**
 - Ítems 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18 y 20. Se invierten de la escala de respuesta directa para que “de acuerdo” sea máxima impulsividad: **Rotundamente de acuerdo = 4 puntos | Algo de acuerdo = 3 puntos | Algo en desacuerdo = 2 puntos | Rotundamente en desacuerdo = 1 punto**.
- **Puntuación de Subescalas:** Suma de los 4 ítems de cada factor (rango: 4 a 16 puntos por subescala).

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntaje Factor (4-16)	Nivel de Impulsividad	Significación Psicopatológica y Vulnerabilidad Clínica
4 – 7 puntos	Impulsividad Baja / Reflexivo	Excelente control inhibitorio y deliberación previa en esa dimensión específica.
8 – 10 puntos	Impulsividad Media / Normal	Nivel adaptativo habitual en población general. Regulación emocional funcional.
11 – 13 puntos	Impulsividad Alta	Umbral clínico de atención. Pérdida frecuente del control o precipitaciones con consecuencias perjudiciales.
14 – 16 puntos	Impulsividad Muy Alta / Crítica	Gravedad patológica severa. Si es Urgencia Negativa: alto riesgo autolítico. Si es Urgencia Positiva: alto riesgo de consumos masivos o juego patológico.

PREDICTOR CLAVE DE LETALIDAD AUTOLÍTICA (VERDEJO-GARCÍA ET AL., 2010): Una puntuación ≥ 13 en **Urgencia Negativa** duplica el riesgo de transitar desde la ideación suicida pasiva hacia la conducta suicida en momentos de angustia afectiva aguda, obligando a instaurar un plan de contingencia.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Administración del perfil pentafactorial UPPS-P:

- Aplicar en pacientes con trastorno límite de la personalidad, adicciones químicas o conductuales (juego, compras compulsivas), TDAH o bulimia nerviosa.

Paso 2: Intervención dirigida al fenotipo de impulsividad detectado:

- **Urgencia Negativa Alta (UN ≥ 12):** Intervención focalizada en tolerancia al malestar (módulos de DBT, técnica TIPP: temperatura, ejercicio intenso, respiración acompasada y relajación pareada).
- **Urgencia Positiva Alta (UP ≥ 12):** Prevención de recaídas focalizada en estados de euforia (celebraciones, pagos de nómina, fiestas); reestructuración de la falsa autoeficacia.
- **Falta de Premeditación Alta (PM ≥ 12):** Entrenamiento en solución de problemas, técnica de parada de pensamiento y anticipación deliberada de consecuencias (**Stop-Think-Act**).
- **Falta de Perseverancia Alta (PS ≥ 12):** Reestructuración ambiental, fragmentación de tareas largas en subtareas breves y técnicas de manejo del TDAH del adulto.

Paso 3: Monitorización terapéutica trimestral:

- Evaluar la reducción en las subescalas de Urgencia como marcador directo de mejoría en la regulación emocional.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 22 años, universitaria, consulta en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria por atracones nocturnos seguidos de vómitos autoinducidos y cortes superficiales en muslos tras discusiones con su pareja.

Resultados en la Escala UPPS-P (20 ítems):

- **Urgencia Negativa (UN): 16 / 16 (Puntuación Máxima -> Desinhibición Afectiva Extrema).**
- Urgencia Positiva (UP): 8 / 16 (Normal, no pierde el control cuando está contenta).
- Falta de Premeditación (PM): 9 / 16 (Capacidad reflexiva normal en frío).
- Falta de Perseverancia (PS): 7 / 16 (Buen rendimiento académico, finaliza sus cursos).
- Búsqueda de Sensaciones (SS): 6 / 16 (Baja, prefiere actividades tranquilas).

Diagnóstico y Enfoque Terapéutico: El perfil del UPPS-P demostró que la paciente no presentaba una impulsividad generalizada ni un déficit atencional (PM y PS normales), sino un déficit específico y masivo de **Urgencia Negativa (UN = 16)**: ante emociones negativas intensas, su corteza prefrontal perdía el control inhibitorio, recurriendo al atracón y a la autolesión como conductas impulsivas de escape del dolor psíquico. Se prescribió Terapia Dialéctica Conductual (DBT) centrada en habilidades de tolerancia al malestar. A los 6 meses, la puntuación de UN descendió a 9/16, con cese absoluto de las autolesiones y reducción del 80% de los atracones.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS CLÍNICAS IMPORTANTES:

- **Riesgo autolítico por Urgencia Negativa:** Pacientes con UN elevada pueden realizar tentativas de suicidio impulsivas con mínima premeditación ante rupturas afectivas agudas.
- **Juego patológico por Urgencia Positiva:** La creencia de "estar en racha" ligada a UP alta es el principal disparador de pérdidas económicas catastróficas.
- **Consumo desinhibidor:** El alcohol anula el control en pacientes con Falta de Premeditación basal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **UPPS-P vs. BIS-11:** La BIS-11 evalúa componentes cognitivos y motores pero ignora por completo la modulación emocional de la impulsividad (Urgencias).
- **TDAH vs. TLP:** En el TDAH predominan la Falta de Premeditación y la Falta de Perseverancia constantes; en el TLP predominan las Urgencias afectivas extremas.
- **Manía Bipolar:** Elevación masiva y simultánea de Urgencia Positiva y Búsqueda de Sensaciones transitoria durante el episodio maniaco.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 30(4), 669–689. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00064-7](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00064-7)
2. Cyders, M. A., Smith, G. T., Spillane, N. S., Fischer, S., Annus, A. M., & Peterson, C. (2007). Integration of affect and impulsivity: the Positive Urgency Scale. *Assessment*, 14(2), 107–120. <https://doi.org/10.1177/1073191106298874>
3. Cándido, A., Orduña, E., Perales, J. C., Verdejo-García, A., & Billieux, J. (2012). Validación empírica de la versión breve de la escala de impulsividad UPPS-P en español. *Revista de Neurología*, 55(8), 455–462.
4. Verdejo-García, A., Lozano, O., Moya, M., Alcázar, M. A., & Pérez-García, M. (2010). Psychometric properties of a Spanish version of the UPPS-P impulsive behavior scale: Reliability, validity and association with neurocognitive performance. *Journal of Personality Assessment*, 92(1), 70–77.